

10 - 08- Les manifestations psychiatriques de la neurosyphilis - Pr. ADALI

(0:01 - 0:29)

Ce qui est important pour la neurosyphilis, c'est surtout le syndrome neurologique. Ça c'est un prérequis, parce que je ne peux pas parler de la neurosyphilis sans parler des symptômes neurologiques, du syndrome neurologique. La dysarthrie, les réflexos tétondideux.

(0:29 - 0:54)

Moi, je ne poserai pas de questions sur le syndrome neurologique. C'est vous qui avez fait la neurologie l'année dernière, pas moi. Donc, je ne poserai pas de questions sur tout ce qui est neurologique, tout ce qui est symptomatologie neurologique, parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon domaine.

(0:57 - 1:09)

D'accord ? Excusez-moi. Les consignes que j'ai données, c'est valable pour la première session. Deuxième session.

(1:12 - 1:49)

Pour ceux qui veulent faire un pass à la psychiatrie, deuxième session. D'accord ? Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir dans la neurosyphilis, c'est la fréquence de symptomatologie psychotique type d'humeur instable, d'excitation hypomaniaque ou mégalomanie.

(1:50 - 2:16)

Beaucoup de pathologies, beaucoup de neurosyphilis peuvent prendre la forme d'accès maniaque ou de symptomatologie maniaque. D'accord ? Le début, c'est un début insidieux. Bien sûr, ça peut être avec un déficit intellectuel.

(2:17 - 2:49)

Ce qui m'intéresse, c'est surtout la symptomatologie psychiatrique avec un changement de caractère, de personnalité, des comportements absurdes ou délectueux. C'est-à-dire des patients qui vont commencer à se dénuder, faire des avances aux filles, se masturber devant leurs enfants, marcher nu à la maison. Ce sont des gestes qui sont insidieux, sans passer à l'acte.

(2:52 - 3:07)

Avec un syndrome démentiel. Troubles d'attention, de la mémoire, du langage. Les troubles psychiatriques, troubles de l'humeur, surtout l'euphorie.

(3:09 - 3:27)

Un syndrome délirant, délire polymorphe, polythématique. Un délire contradictoire, flou, mal systématisé, parfois des hallucinations. Il y a des formes à début aiguës aussi, sous forme d'excitation maniaque ou hypomaniaque.

(3:29 - 3:58)

Le diagnostic différentiel, surtout dans les formes aiguës, c'est les troubles de l'humeur. Je ne poserai pas de questions sur le traitement PNJ. Par contre, il faut savoir que le traitement de la neurosyphilis, c'est un traitement étiologique, PNJ et tout, avec un traitement psychiatrique symptomatique.

(3:59 - 4:28)

Quand vous avez un patient qui est en excitation maniaque et qui a une neurosyphilie, il ne va pas se stabiliser. Est-ce que vous avez des questions ? Il se peut qu'à 100%, je ne pose pas de questions sur la neurosyphilie. Il se peut à 100% que je ne pose pas de questions sur la neurosyphilie.

(4:29 - 4:44)

Il se peut à 100% que je ne pose pas de questions sur les troubles psychosomatiques. Il se peut à 100% que je pose des questions sur les caractéristiques des troubles mentaux critiques. Des bubbes brefs, etc.

(4:47 - 5:13)

Et il se peut que je pose aussi une question sur la psychose purporelle et sur le paranoïa. À 100%. Ça fait.

(5:14 - 5:20)

S'il vous plaît. C'est maintenant. À 100%, il se peut.

(5:27 - 5:34)

Les caractéristiques. Il se peut, il ne se peut pas. Il ne se peut pas à 100%.

(5:40 - 5:50)

Ça c'est valable pour. Il se peut que ce soit valable à 100% pour la première session. D'accord ? Deuxième session.

(5:52 - 6:10)

Deuxièmement, si vous vous amusez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions maintenant ? Oui, dites-moi. Qui est en train de parler ? Oui. Chez ? Avec ? Non, non, non.

(6:10 - 6:25)

Heureusement. L'incidence des troubles psychiatriques chez les patients épileptiques, c'est-à-dire les troubles psychiatriques dus à l'épilepsie, elle est rare. Mais par contre, elle est assez rare, ce n'est pas très fréquent.

(6:26 - 6:46)

C'est un facteur de mauvais pronostic qui l'accueille. Par contre, ce qu'on voit chez les patients épileptiques, comme tout malade qui a une pathologie chronique, c'est la dépression. Il va déprimer à cause de l'épilepsie et il va déprimer aussi à cause de l'handicap que l'épilepsie peut causer.

(6:47 - 7:09)

Les patients épileptiques, surtout ceux qui ne sont pas stabilisés, ce sont les neurologies. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ? Ils ne peuvent pas conduire, ils ne peuvent pas conduire les poids lourds, ils ne peuvent pas travailler dans le blessement. Ils ne peuvent pas nager, ils ont beaucoup d'handicaps dans leur vie.

(7:09 - 7:23)

Donc, les restrictions peuvent causer une dépression parce que c'est une pathologie chronique. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est une épilepsie avec des troubles psychiatriques. L'épilepsie peut se compliquer de dépression.

(7:24 - 7:46)

Généralement, une fois traité, ça rentre dans l'ordre. Mais heureusement, non, les épileptiques, heureusement pour nous et pour eux. Oui, est-ce que vous avez des questions ? Je vais vous poser une question.

(7:46 - 8:09)

Qu'est-ce qu'un secteur ? Un secteur ou un réseau ? Qu'est-ce qu'un réseau ? Un réseau, un réseau, un réseau. Le réseau, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un réseau d'Internet grand ou d'Internet petit ? Le réseau est comme une toile d'araignée. Qu'est-ce qu'un secteur ? Un seul domaine de la vie.

(8:11 - 8:20)

Le réseau, qu'est-ce qu'il y a ? Plusieurs domaines. Le secteur ou le réseau ? Le réseau. Donc le

réseau, il y a plusieurs domaines ou un seul domaine de la vie ? Plusieurs domaines.

(8:21 - 8:44)

Secteur ? Petit ? Oui. Les autres ? Oui. Rationalisme morbide, c'est un exemple clair en deuxième année, puisque c'est le même exemple que je donne chaque année.

(8:45 - 9:10)

Rationalisme morbide, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un raisonnement pseudo-scientifique ou la pseudo-philosophie d'un patient. Généralement, ce sont des patients schizophrènes qui ont le rationalisme morbide. On avait un étudiant qui avait des hallucinations intra-psychiques, c'est-à-dire qu'il entendait des voix à l'intérieur de sa tête.

(9:11 - 9:22)

Ce sont des hallucinations. C'est un étudiant qui voulait rationaliser. C'est-à-dire qu'il voulait expliquer ces hallucinations avec un raisonnement pseudo-scientifique.

(9:23 - 9:37)

C'est un étudiant, je crois qu'il était en biologie. En tout cas, il suivait une branche scientifique. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a dit qu'il a bu quelque chose de salé.

(9:38 - 10:00)

Il a dit qu'il a bu quelque chose de salé parce que tout ce qu'on avale passe dans le sang. Le sang irrigue le cerveau. Est-ce que c'est un raisonnement logique ? Pseudo-logique.

(10:00 - 10:19)

On ne peut pas dire qu'il est illogique et qu'il est logique. Oui ou non ? C'est un raisonnement pseudo-logique. Un phénomène, il va l'expliquer d'une façon pseudo-religieuse, pseudo-philosophique.

(10:19 - 10:49)

C'est ça le rationalisme. Les autres ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questionnements ? Oui, monsieur. Par le stress, bien sûr.

(10:50 - 11:23)

L'épilepsie, les pathologies psychosomatiques que j'ai citées, oui, elles peuvent être aggravées par un facteur de stress. Beaucoup de pathologies neurologiques sont aggravées par le stress. Est-ce que vous avez des questions ? Les questions sont claires.

(11:24 - 11:35)

En tout cas, ma partie est là. En tout cas, je vais parler de ma partie. Mes questions sont claires.

(11:38 - 12:11)

Généralement, avec le taux de réussite qu'on a en psychiatrie, les personnes qui n'ont pas la psychiatrie en première session, c'est qu'ils ne l'ont pas lue. Généralement, la psychiatrie, c'est une matière qui se trouve dans la première session, pas dans la deuxième session. Nos questions sont claires.

(12:12 - 12:30)

En tout cas, mes questions sont claires. Les questions sont claires. Profitez de la première session pour avoir votre matière.

(12:31 - 12:47)

D'accord, les questions, on ne pose pas de questions pièges, on ne pose pas des questions sur des choses qu'on a dites uniquement à l'amphithéâtre, pas du tout. On pose des questions sur tout ce qui est dans les diapositives. Moi, je parle de ma partie.

(12:55 - 13:09)

Non. Non, la dysmorphophobie, c'est que je suis mal formé. Mais si je suis obèse, obèse, c'est autre chose.

(13:09 - 13:18)

Je suis mal formé. C'est une malformation physique. L'obésité, ce n'est pas une malformation.

(13:19 - 13:33)

D'accord, est-ce que c'est clair pour toi? C'est une malformation, soit au niveau du visage, soit au niveau physique. Généralement, c'est une malformation au niveau du visage. Je suis déformé.

(13:33 - 14:03)

Mais je suis obési. Non, c'est différent. Un corps étranger? À l'intérieur d'eux? D'où est-ce que tu as eu cet exemple? Alors, c'est quoi? Justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question.

(14:04 - 14:12)

C'est dissocié, c'est de la dissociation, c'est de la dépersonnalisation. C'est probablement un schizophrène. Ce n'est pas une hypochondrie.

(14:12 - 14:31)

L'hypochondrie, si tu reviens à la définition, c'est la conviction inébranlable qu'on a une maladie grave, incurable. Mais ce que tu rapportes là, c'est un syndrome dissociatif, c'est une dépersonnalisation dans le cadre d'un syndrome dissociatif. Et un être vivant qui vit dans le corps.

(14:32 - 14:39)

C'est l'idée qui geste ainsi. C'est le système dissociatif qui geste. Bizarre.

(14:40 - 14:50)

C'est une bizarrerie idéique. Quand vous avez une idée bizarre, il faut penser à la dissociation schizophrénique. Il faut penser à la schizophrénie.

(14:50 - 15:03)

Non, ce n'est pas une hypochondrie. Ça fait? Est-ce que vous avez des questions?